

Wytyczne

w sprawie zasad funkcjonowania i obsługi umów obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych zawieranych z wykorzystaniem Platformy Everest, taryf składek za te ubezpieczenia oraz zmian w Instrukcji Statystycznej.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH

1. Klasyfikacja ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwane dalej „ubezpieczeniem obowiązkowym OC podmiotu leczniczego”, zalicza się do Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, grupy 13 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12, zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) – „Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń”.

2. Podstawa prawna zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego

Podstawowe zasady zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego, w tym umów ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”. Obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego innych niż określone w art. 4 pkt 1 – 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, w których zwykle zawarta jest delegacja do wydania aktu wykonawczego, określającego warunki danego ubezpieczenia obowiązkowego.

Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem cywilnym” (art. 22 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego przez zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia (art. 5 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Jeżeli zakład ubezpieczeń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za jej przyjęcie (art. 5a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom ustawy lub odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia (art. 10 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy (art. 10 ust. 1a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Oznacza to, że jeżeli ubezpieczający

spóźni się z zawarciem (wznowieniem) ubezpieczenia to może mieć przerwę w ubezpieczeniu i pozostać bez ochrony ubezpieczeniowej.

Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym (art. 10 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Ponieważ to na podmiocie leczniczym spoczywa obowiązek ubezpieczenia należy pamiętać, że co do zasady ubezpieczającym będzie podmiot leczniczy, a nie zakład leczniczy tego podmiotu.

4. Zakres umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres umowy ubezpieczenia obowiązkowego określonego w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, wykonywaniu zawodu albo prowadzeniu działalności lub będące następstwem wad produktu, określoną w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską (art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej określonego w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (art. 11 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Natomiast umowa ta nie obejmuje swoim zakresem szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego umyślnie (a contrario art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

5. Regres

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, a także w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

6. Koszty pokrywane w ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu:

- 1) uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody;
- 2) niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń (art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Część II

INFORMACJE OGÓLNE O PODMIOTACH LECZNICZYCH I DZIAŁNOŚCI LECZNICZEJ

1. Podmioty lecznicze a podmioty wykonujące działalność leczniczą

1.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o działalności leczniczej”, definiuje podmiot wykonujący działalność leczniczą jako:

- 1) podmiot leczniczy, przez który rozumie się:
 - a) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 r. poz. 584, z późn.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa o działalności leczniczej nie stanowi inaczej (np. podmioty lecznicze prowadzone w formie sp. z o.o.),
 - b) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- c) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) (np. szpitale MSWiA),
- d) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) (np. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie),
- e) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne tych stowarzyszeń,
- f) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
- g) jednostki wojskowe

- w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą;

2) lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, przy czym:

- a) działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:
 - jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 - spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
- b) działalność lecznicza pielęgniarek może być wykonywana w formie:
 - jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
 - spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

1.2. Przedmiotem niniejszych wytycznych są wyłącznie zasady funkcjonowania i obsługi umów obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.

2. Rodzaje działalności leczniczej oraz świadczeń zdrowotnych

2.1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej). Rodzajami działalności leczniczej, zgodnie z art. 8 ustawy o działalności leczniczej, są:

- a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
- b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
- c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.2. Świadczenie zdrowotne

2.2.1. Świadczenie zdrowotne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Ustawa o działalności leczniczej określa także świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach danego rodzaju działalności leczniczej oraz wskazuje miejsca udzielania tych świadczeń.

2.2.2. Świadczenie szpitalne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej, wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

2.2.3. Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne to, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzdrowiskowego, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach.

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne mogą polegać w szczególności na:

- a) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i żywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; świadczeń tych udziela się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym¹,
- b) udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i żywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; świadczeń tych udziela się w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym¹,
- c) udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; świadczeń tych udziela się w zakładzie rehabilitacji leczniczej¹,
- d) sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów; w hospicjum¹.

2.2.4. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.

Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium

¹ art. 9 i 12 ust 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.

diagnostycznym oraz w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych.²

CZĘŚĆ III

WARUNKI OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. **Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotów leczniczych** regulują:
 - 1) ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 - 2) ustawa o działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o działalności leczniczej. Ustawa o działalności leczniczej określa m. in.:
 - a) zasady wykonywania działalności leczniczej,
 - b) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 - c) zasady sprawowania nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.Ustawa o działalności leczniczej wprowadza pojęcia istotne dla właściwej interpretacji zasad dotyczących obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla sektora medycznego. Znajomość tych definicji jest istotna, m.in. dla właściwej interpretacji rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3, zapisów OWU ubezpieczenia podmiotów leczniczych prowadzących szpital oraz taryf składek, o których mowa w dalszych częściach niniejszych wytycznych;
 - 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729), dalej zwane „rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego”.

2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego

2.1. Minister Finansów, wykonując delegację zawartą w art. 25 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, wydał rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego określa szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

2.2 Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ciąży na podmiocie leczniczym a nie na zakładzie leczniczym. Zakład leczniczy to zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej³. Zakład leczniczy jest jednostką lokalną w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), dla której nie sporządza się odrębnego bilansu, chyba że podmiot leczniczy postanowi inaczej w regulaminie organizacyjnym⁴.

2.3 Ubezpieczeniem obowiązkowym OC podmiotu leczniczego objęta jest, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Jak z powyższego wynika mamy tu do czynienia z triggerem act committed.

² art. 10, 11 i 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

³ art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności leczniczej.

⁴ art. 2 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia (uwaga: zabiegi chirurgii plastycznej lub zabieg kosmetyczny inne niż wskazane powyżej nie są objęte zakresem ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego).

Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu leczniczego nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
- 2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
- 3) polegających na zapłacie kar umownych;
- 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

2.4. Minimalne sumy gwarancyjne. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego zróżnicowana jest w zależności od rodzaju i formy wykonywania działalności leczniczej i wynosi równowartość w złotych:

1) 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w części II, ust. 2 pkt 2.1 lit. a⁵, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne⁶;

2) 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w części II, ust. 2 pkt 2.1 lit. b i c⁷, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne⁸;

Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej⁹.

Przykład:

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w dwóch zakładach leczniczych:

- a) w jednym z nich wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne (czyli prowadzi szpital),
- b) w drugim - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (np. prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy).

Minimalna suma gwarancyjna wymagana od podmiotów leczniczych prowadzących:

- a) szpital to 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego
- b) zakład opiekuńczo-leczniczy to 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego.

W celu spełnienia obowiązku ubezpieczenia podmiot leczniczy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego z sumą gwarancyjną w wysokości 100.000 euro w odniesieniu do

⁵ art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

⁶ art. 8 pkt 1 lit. a ustawy o działalności leczniczej

⁷ art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

⁸ art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy o działalności leczniczej

⁹ § 3 ust 2 rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego

jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego.

Na ekranie oferty w Everest - suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia i suma gwarancyjna w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, w zależności od wyboru kategorii świadczeń zdrowotnych jest już wpisana domyślnie.

Kwoty minimalnej sumy gwarancyjnej ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego została zawarta.

3. Okres ubezpieczenia

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego odnosi się do okresu ubezpieczenia nie dłuższego niż 12 miesięcy¹⁰. Oznacza to, że nie można zawrzeć umowy ubezpieczenia z okresem dłuższym niż 1 rok.

4. Termin powstania obowiązku ubezpieczenia

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej (art. 25 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej).

CZĘŚĆ IV

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Ogólne warunki ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego

1.1. W zakresie dobrowolnych warunków ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego zastosowanie będą miały niżej wymienione ogólne warunki ubezpieczenia. Warunki te zostały wydane w dwóch wersjach:

1) adresowanej do podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital - w tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwane dalej „OWU”;

2) adresowanej do podmiotów leczniczych prowadzących szpital - w tym przypadku zastosowanie znajdą ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych prowadzących szpital ustalone uchwałą nr UZ/452/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwane dalej „OWU szpitali”.

1.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących szpital skierowane jest - zgodnie z obowiązującą procedurą segmentacji klientów - do klienta korporacyjnego i obsługiwane jest przez pracowników PKK. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital są kierowane do każdego segmentu klientów.

1.3. Konstrukcja OWU i OWU szpitali umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia OC w jednym z dwóch wariantów ubezpieczenia:

1) podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego (zakres potocznie nazywany OC medyczną);

¹⁰ § 3 ust 1 Rozporządzenia

- 2) rozszerzony zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w tym udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowo o zakresach ubezpieczenia w ust. 2.

Co istotne – ubezpieczający może wybrać wyłącznie jeden z tych wariantów. Wybrany wariant może zostać rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych stanowiących załącznik do OWU albo OWU szpitali, przy czym klauzule: Nr 5 (OC pracodawcy), Nr 6 (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu), Nr 7 (OC najemcy nieruchomości i ruchomości), Nr 10 (OC za szkody w mieniu przechowywanym), Nr 80 (OC ośrodka badawczego), Nr 81 (OC z tytułu eksperymentów badawczych) mogą być zastosowane wyłącznie gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest w wariancie rozszerzonym (§ 10 ust. 2 OWU i OWU szpitali).

2. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia OC (dobrowolnego)

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie:

- 1) udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego (zakres podstawowy) albo
- 2) działania lub zaniechania działania ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w tym udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (zakres rozszerzony).

2.2. Wyrządzenie szkody na osobie jest czynem niedozwolonym, z którym wiąże się odpowiedzialność deliktowa. Zasady odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych zostały określone w art. 415 – 449 kodeksu cywilnego. Źródłem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego może być również istniejące pomiędzy stronami zobowiązanie np. umowa zawarta pomiędzy prywatnym szpitalem, a pacjentem. Podstawowe regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zawarte są w art. 471-486 kodeksu cywilnego.

Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego zobowiązania umownego (odpowiedzialność kontraktowa) jest jednocześnie czynem niedozwolonym, a zawsze jest nim wyrządzenie szkody na osobie, zachodzić będzie bieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej - art. 443 kodeksu cywilnego.

2.3. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Oznacza to, że w ramach zawartej umowy ubezpieczenia OC nie będą objęte szkody, jeżeli wynikać będą z odpowiedzialności szerszej niż ustawowa, którą nasz klient przyjął na siebie w umowie z jego kontrahentem.

2.4. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wybranego przez ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia określonego w OWU i OWU szpitali:

- 1) § 7 OWU i OWU szpitali - podstawowy zakres ubezpieczenia albo
- 2) § 8 OWU i OWU szpitali - rozszerzony zakres ubezpieczenia.

Każdy z zakresów ubezpieczenia ma odrębnie zdefiniowane pojęcie wypadku ubezpieczeniowego. Podstawowy zakres ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do szkód wyrządzonych z tytułu udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia PZU udziela ochrony ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, w

tym udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczający może wybrać wyłącznie jeden z powyższych zakresów.

Każdy z wymienionych zakresów obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej w zakresie:

- 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

2.5. O ile nie umówiono się inaczej, warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w podstawowym zakresie ubezpieczenia albo w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia jest zawarcie z PZU umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2.6. Szkody wyrządzone przez osoby, którymi ubezpieczony się posługuje uregulowane zostały według poniższych zasad.

2.6.1. Szkody wyrządzone przez pracownika. Z zastrzeżeniem postanowień OWU i OWU szpitali, w szczególności § 9, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego. PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec pracownika (§ 6 ust. 3 OWU i OWU szpitali). Zwracamy uwagę na katalog osób, które zostały uznane za pracowników (§ 4 pkt 9 OWU i OWU szpitali).

2.6.2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców. Szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za własne działania objęte są ubezpieczeniem z zachowaniem prawa do regresu (gdy zakres odpowiedzialności nie został rozszerzony o klauzulę Nr 13M). Zasady przejścia roszczeń na ubezpieczyciela określa art. 828 K.c.

Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której ubezpieczony powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie (§ 4 pkt 8 OWU i OWU szpitali).

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców przewidziana jest w ramach obu reżimów odpowiedzialności (deliktowej oraz kontraktowej) określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

W przypadku odpowiedzialności deliktowej ubezpieczony będzie odpowiadał na podstawie art. 429 K.c. zgodnie z którym osoba powierzająca wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Aby uwolnić się od odpowiedzialności, ubezpieczony musi udowodnić, że nie ponosi winy w wyborze, albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Odpowiedzialność kontraktowa ubezpieczonego obejmuje odpowiedzialność za działania lub zaniechania innych osób w sytuacji określonej w art. 474 K.c. Za działania i zaniechania osób, z pomocą których ubezpieczony wykonuje zobowiązanie (kontrakt), odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie. Oznacza to, że ubezpieczony (dłużnik) odpowiada za takie zachowanie osób trzecich, jak za własne działanie, które jemu mogłoby być przypisane jako zawinione, gdyby sam wykonywał zobowiązanie. Dłużnik z mocy ustawy odpowiada za te osoby na zasadzie ryzyka, a więc np. nie będzie mógł się powołać na brak własnej winy w wyborze. Natomiast dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeśli wykaże okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego podwykonawcy, ten ostatni jest osobą trzecią w rozumieniu OWU.

3. Wypadek ubezpieczeniowy

3.1. Definicja wypadku ubezpieczeniowego różni się w zależności od zakresu ubezpieczenia.

W odniesieniu do podstawowego zakresu ubezpieczenia – wypadkiem ubezpieczeniowym jest udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

W odniesieniu do rozszerzonego zakresu ubezpieczenia jest to działanie lub zaniechanie działania przez ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem, w tym udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda.

W obu wariantach ubezpieczenia zastosowano trigger act committed.

3.2. Z pojęciem wypadku ubezpieczeniowego nierozdzielnie wiąże się pojęcie triggera, choć to drugie jest znacznie szersze, bowiem nie ogranicza się wyłącznie do definicji wypadku ubezpieczeniowego a dla jego zrozumienia i funkcjonowania mają również znaczenie definicja daty początkowej, daty retroaktywnej, okresu dodatkowego (extended reported period) czy klauzula szkód seryjnych.

Triggery w ujęciu modelowym (jednak w praktyce bardzo często są modyfikowane – zastrzane, łagodzone):

1) act committed - oparty na wystąpieniu pierwotnej przyczyny szkody (najdalej odsunięte w przeszłości zdarzenie, z którym można wiązać powstanie szkody); wypadkiem ubezpieczeniowym, warunkującym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, które doprowadziło do wyrządzenia szkody; taki trigger obowiązuje w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych OC podmiotów leczniczych;

2) occurrence - oparty na przyczynie sprawczej (zdarzenie bezpośrednio wyrządzające szkodę); warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest wystąpienie w okresie ubezpieczenia zdarzenia wyrządzającego szkodę;

3) loss occurrence - wystąpienie szkody; odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje, o ile w okresie ubezpieczenia powstanie szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową;

4) loss manifestation – odpowiedzialność ubezpieczyciela uwarunkowana jest z ujawnieniem się szkody;

5) claims made – odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje, gdy w okresie ubezpieczenia po raz pierwszy zostanie zgłoszone roszczenie odszkodowawcze.

4. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umówiono się inaczej (§ 6 ust. 2 OWU i OWU szpitali) i do umowy ubezpieczenia wprowadzono postanowienia dodatkowe w postaci jednej z klauzul terytorialnych, stanowiących załącznik do OWU i OWU szpitali.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

5.1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 9 OWU i OWU szpitali ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

Wyłączenia odpowiedzialności są zapisami uniwersalnymi, obowiązującymi zarówno dla podstawowego zakresu ubezpieczenia, rozszerzonego zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych. Wyłączenia ustalone w klauzulach dodatkowych, stanowią łącznie z innymi wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU i OWU szpitali obowiązujący katalog wyłączeń ograniczający odpowiedzialność PZU.

Wyłączenia odpowiedzialności dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:

- 1) wyłączenia bezwzględne;
- 2) wyłączenia względne.

5.2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne (obligatoryjne) dotyczą z reguły wypadków, gdy postępowanie osoby wyrządzającej szkodę można uznać za rażąco naganne i zgodnie z aktualną polityką ubezpieczeniową zostały wykluczone z ochrony np. szkoda wyrządzona w stanie nietrzeźwości, szkoda wyrządzona przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (zawodu, czynności), albo postrzegane są jako zbyt duże ryzyko ubezpieczeniowe np. naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka, szkody wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania do starannego działania, szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje szkód, roszczeń, ryzyk wskazanych w tych wyłączeniach co do zasady nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej.

5.3. Wyłączenia odpowiedzialności względne (fakultatywne) dotyczą wypadków ubezpieczeniowych, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile zostały wprowadzone do umowy ubezpieczenia na podstawie postanowień dodatkowych lub odbiegających od uregulowań OWU i OWU szpitali. Wyłączenia względne zostały wymienione w § 10 ust. 1 OWU i OWU szpitali. Ogólne zasady wprowadzania do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odbiegających od uregulowań OWU zostały określone w § 2 ust. 1 OWU i OWU szpitali.

6. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia

6.1. Klauzule dodatkowe, rozszerzające zakres ubezpieczenia, stanowią uzupełnienie zakresu oferowanego w OWU i OWU szpitali, określonego w § 7 i § 8. Rozszerzenie ubezpieczenia dokonane jest jednak tylko w takim zakresie w jakim zostało to ustalone w klauzulach (postanowieniach dodatkowych lub odmiennych).

Klauzule te możemy podzielić na:

- 1) klauzule standardowe tj. zawarte w załączniku do OWU i OWU szpitali, stanowiącym integralną część OWU i OWU szpitali;
- 2) klauzule niestandardowe, które nie stanowią integralnej części OWU i OWU szpitali, ich treść jest jednak ustalona we wzorze postanowień odmiennych od OWU i OWU szpitali, który stanowi załącznik do uchwały Zarządu PZU w sprawie ustalenia OWU i OWU szpitali.

Tabela zastosowania klauzul dodatkowych stanowiących załącznik do OWU i OWU szpitali

Nazwa klauzuli	Zastosowanie klauzul dodatkowych			
	OWU podmiotów leczniczych		Zakres ubezpieczenia	
	innych niż prowadzą-	Prowadzących szpital	Podstawowy	Rozszerzony

	ce szpital		(§ 7)	(§ 8)
Klauzula Nr 1 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 2 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 3 M Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności o szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 4M Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 4AM Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula nr 7 A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości)	Tak	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)	Nie	Tak	Nie	Tak
Klauzula Nr 13M Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu	Tak	Tak	Tak	Tak
Klauzula Nr 80 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego	Nie	Tak	Nie	Tak

Klauzula Nr 81 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych	Nie	Tak	Tak	Tak
--	-----	-----	-----	-----

6.2. Klauzule dodatkowe stanowiące załącznik do OWU i OWU szpitali

6.2.1. Klauzule terytorialne

Klauzule terytorialne umożliwiają rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły:

- 1) na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (Klauzula nr 1M),
- 2) na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (Klauzula 2M),
- 3) na terenie całego świata (klauzula 3M).

Wymienione klauzule terytorialne są klauzulami jednorazowego wyboru, tzn. w umowie ubezpieczenia należy wskazać tylko jedną klauzulę terytorialną obejmującą wnioskowany zakres terytorialny.

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w ramach wymienionych klauzul, jest posiadanie wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu na terytorium kraju, w którym zawód jest wykonywany.

Klauzule mają zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.2. Klauzule dotyczące chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej

6.2.2.1. Klauzula Nr 4M - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej)

W ramach standardowej ochrony ubezpieczeniowej PZU nie odpowiada za szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia (§ 10 ust. 1 pkt 2 OWU i OWU szpitali).

Postanowienie to ma na celu wyłączenie z podstawowej ochrony ubezpieczeniowej chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów kosmetycznych, których celem jest usunięcie tzw. „błędu piękności” lub wyłącznie polepszenie wyglądu zewnętrznego. Włączenie do ubezpieczenia tego ryzyka możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie klauzuli dodatkowej Nr 4M i pobranie z tego tytułu dodatkowej składki. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej lub zabiegów medycyny estetycznej.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.2.2. Klauzula Nr 4AM - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek stosowania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej (OC zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej).

Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody będące następstwem zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami wykonywania zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zabiegów chirurgii plastycznej.

Włączenie do ubezpieczenia tego ryzyka możliwe jest jedynie poprzez zastosowanie klauzuli dodatkowej 4AM i pobranie z tego tytułu dodatkowej składki. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli stosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami zabiegów medycyny estetycznej.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.3. Odpowiedzialność ubezpieczonego za wypadki przy pracy

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 5 (OC pracodawcy) i za zapłatą dodatkowej składki.

W rozumieniu OWU i OWU szpitali, za pracownika zostały uznane osoby fizyczne (§ 4 pkt 9 OWU i OWU szpitali):

- 1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
- 2) zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca;
- 3) praktykanci, stażyści, wolontariusze, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

Pojęcie „pracownika” w OWU i OWU szpitali jest szerokie. Na równi z umową o pracę traktuje się umowy cywilnoprawne oraz inne przypadki powierzenia przez ubezpieczonego wykonywania pracy.

Klauzula Nr 5 obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone pracownikowi. Odszkodowanie za rzeczy uszkodzone czy zniszczone w wypadku przy pracy, będzie przysługiwać na podstawie klauzuli Nr 5, mimo braku szkody na osobie.

Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone świadczenia przysługujące poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Wyrządzenie pracownikowi szkody nie będącej następstwem wypadku przy pracy objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wynikającego z OWU.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.4. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 6 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu) i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula Nr 6 rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Zapewnia także pokrycie kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji.

Dla przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej niezbędne jest, aby:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona ani niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przedostanie się niebezpiecznej substancji musi być stwierdzone w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia się procesu przedostawania się niebezpiecznej substancji;
- 4) przyczyna przedostania się niebezpiecznej substancji musi zostać potwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Ta klauzula istotna jest w szczególności dla podmiotów leczniczych, które w ramach swej działalności zajmują się również utylizacją odpadów medycznych, prowadzą pralnię chemiczną.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.5. Odpowiedzialność ubezpieczonego z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody z tytułu najmu, dzierżawy etc. cudzej rzeczy możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 7 A - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości i ruchomości) i za zapłatą dodatkowej składki.

Ta klauzula stwarza możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Klauzula zawiera wyłączenia dostosowane do przedmiotu korzystania z rzeczy cudzej.

W klauzuli należy zwrócić uwagę na zawężenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu utraty rzeczy wyłącznie do szkód powstałych w wyniku ich zniszczenia lub uszkodzenia. Dla najemcy rzeczy ruchomych będzie to w praktyce oznaczać brak ochrony za szkody powstałe w następstwie kradzieży czy zaginięcia rzeczy.

Dodatkowo klauzula nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej najemcom rzeczy ruchomych, gdy przedmiotem najmu są pojazdy (wszelkiego rodzaju pojazdy, nie tylko pojazdy mechaniczne). Wyłączone z ubezpieczenia zostały szkody, które powstały w pojazdach, ich wyposażeniu oraz rzeczach pozostawionych w tych pojazdach (ust. 2 pkt 4 klauzuli).

W przypadku prac budowlano-montażowych lub remontowych (nieruchomości) albo naprawczo-remontowych (ruchomości), dokonywanych przez najemcę, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie naprawy konieczne, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ust. 2 pkt 5 klauzuli)¹¹ Ochrona nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych w następstwie prac innych niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, do których wykonania ubezpieczony jest zobowiązany wyłącznie na podstawie umowy pomiędzy najemcą, a wynajmującym.

6.2.6. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym)

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 10 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym) i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula przeznaczona jest dla podmiotów leczniczych, które w ramach prowadzonej działalności prowadzą też usługi przechowywania mienia (np. szatnie, depozyty, magazyny itp.). Przypominamy, że klauzula ta nie dotyczy przechowywania pojazdów oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach (wyłączenie ust. 2 pkt 3 klauzuli).

Ochrona udzielana na podstawie powyższej klauzuli nie obejmuje szkód w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz innych podobnych umów oraz

¹¹ – patrz art. 681 k.c.

pojazdach najmowanych, dzierżawionych, użytkowanych lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie podobnych umów.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.7. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 13 M - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu i za zapłatą dodatkowej składki.

OWU w zakresie podstawowym przewidują ochronę ubezpieczeniową za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. Klauzula Nr 13 M znosi to prawo, powodując tym samym, że odszkodowania wypłacone z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców nie będą regresowane do nich i obciążą wynik umowy ubezpieczenia, zawartej z PZU przez ubezpieczającego.

Rozszerzenie ubezpieczenia w ramach Klauzuli Nr 13 nie powoduje, iż podwykonawca może być utożsamiany z pojęciem ubezpieczonego. Celem rozszerzenia ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez podwykonawców nie jest objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podwykonawców (nie są traktowani jako ubezpieczeni), ale odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców i rezygnacja przez PZU z dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania (po przejściu roszczeń zgodnie z art. 828 K.c. od podwykonawcy – sprawcy szkody).

Definicja podwykonawcy oraz zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców zostały omówione także w punkcie 6.2.7. powyżej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU, który otrzyma w takich wypadkach kopię umowy obustronnie parafowaną oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Klauzula ma zastosowanie do OWU i OWU szpitali, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia (podstawowy zakres ubezpieczenia - § 7 albo rozszerzony zakres ubezpieczenia - § 8).

6.2.8. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli nr 80 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego i za zapłatą dodatkowej składki.

Klauzula nie obejmuje swoim zakresem m.in. szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora oraz powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami Prawo farmaceutyczne.

Klauzula jest dedykowana podmiotowi leczniczemu, który występuje w roli ośrodka badawczego. Z taką sytuacją spotykamy się w szczególności, kiedy na terenie szpitala prowadzone są przez badacza i sponsora badania lecznicze, natomiast szpital ma obowiązek, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy, np. zapewnić odpowiedni personel podczas prowadzenia tego badania, zapewnić odpowiednie pomieszczenia, czy w końcu zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji medycznej w związku z prowadzonym badaniem klinicznym.

Klauzula ma zastosowanie do OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.2.9. Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego możliwe jest poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia Klauzuli Nr 81 - Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych i za pobraniem dodatkowej składki.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, po otrzymaniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną. Podkreślić należy, że ochrona nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych substancji leczniczych, o których mowa w ustawie prawo farmaceutyczne oraz badań klinicznych wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty posługuje się pojęciem eksperymentu medycznego (art. 21 ust. 1 ustawy) i w ramach tegoż eksperymentu wyróżnia eksperyment leczniczy i eksperyment badawczy.

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca (art. 21 ust. 2 ustawy). Eksperyment ten, co do zasady, jest objęty ochroną w ramach obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, gdyż mieści się w definicji świadczenia zdrowotnego, którego podstawowym celem jest zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia pacjenta.

Eksperyment badawczy może być przeprowadzany na osobach chorych i osobach zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. Ponieważ celem tego eksperymentu jest rozszerzenie wiedzy medycznej, nie mieści się on w definicji świadczenia zdrowotnego i przyjęcie ochrony za szkody wyrządzone w związku z przeprowadzaniem eksperymentu badawczego możliwe jest wyłącznie poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia przedmiotowej klauzuli.

Klauzula ma zastosowanie do OWU szpitali, o ile wybrano rozszerzony zakres ubezpieczenia (§ 8).

6.3. Klauzule niestandardowe zawarte we Wzorze postanowień odmiennych dotyczących pokrycia czasowego odpowiedzialności opartego o trigger claims made do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem OWU i OWU szpitali.

6.3.1 Zmiana pokrycia czasowego odpowiedzialności (trigger claims made)

Generalna reguła pokrycia czasowego odpowiedzialności w ubezpieczeniach OC wyrażona jest art. 822 § 2 K.c., stanowiącym, że jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia OC obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia (trigger act committed).

Zastosowanie triggera claims made jest możliwe na podstawie art. 822 § 3 K.c., który przewiduje, że „strony mogą postanowić, że umowa ubezpieczenia będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia”.

Postanowienia klauzuli nr 71 AM pozwalają na zmianę obowiązującego w OWU triggera act committed na trigger claims made¹². Zmiana ta będzie dokonana poprzez modyfikację standardowej definicji wypadku ubezpieczeniowego, przez który zgodnie z postanowieniami odmiennymi będziemy rozumieć wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym roszczenia.

Oznacza to, że niezależnie od tego kiedy doszło do działania lub zaniechania działania skutkującego szkodą, powstania lub ujawnienia się szkody, PZU odpowiadać będzie z tytułu roszczeń wniesionych po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Proces inkubacji szkody może być rozciągnięty przez długie lata. Dodatkowo, w przypadku klientów ubezpieczonych od wielu lat w PZU, jeżeli wcześniejsze umowy ubezpieczenia OC oparte były o trigger act committed, dojść może do kumulacji sum gwarancyjnych. Między innymi z tego powodu, istotne jest określanie w umowie ubezpieczenia:

- 1) daty początkowej - wyłączone zostaną szkody, wynikające lub związane z jakimkolwiek postępowaniem sądowym rozstrzygniętym uprzednio albo będącym w toku przed datą początkową, lub z jakimkolwiek innym postępowaniem niż sądowe;
- 2) daty retroaktywnej - wyłączone zostaną roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń (działanie lub zaniechanie działania, udzielanie bądź niezgodne z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych), mających miejsce przed datą retroaktywną.

Cechą umów ubezpieczenia opartych na triggerze claims made jest zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Roszczenia zgłoszone po upływie okresu ubezpieczenia nie są objęte ubezpieczeniem. Wprowadzając do umowy ubezpieczenia okres dodatkowy, wydłużamy de facto okres udzielanej ochrony, przy czym pamiętać należy, że w okresie dodatkowym można zgłosić roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń mających miejsce przed upływem okresu ubezpieczenia.

Przykład

Umowa ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego została zawarta w oparciu o trigger claims made

Okres ubezpieczenia 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.

Data początkowa: 01.01.2016 r.

Data retroaktywna: 01.01.2010 r.

Okres dodatkowy: 12 miesięcy

Przykład działania daty początkowej

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Do momentu zgłoszenia roszczenia nie toczyło się w tej sprawie żadne postępowanie sądowe oraz inne niż sądowe. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po dacie początkowej.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Postępowanie sądowe w tej sprawie toczyło się od dnia 01.02.2016 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po dacie początkowej.

Przykład działania daty retroaktywnej

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po dacie retroaktywnej.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.06.2016 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2009 r. Roszczenie nie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce przed datą retroaktywną.

Przykład działania dodatkowego okresu

¹² O triggerach patrz Część IV, pkt 3 Wypadek ubezpieczeniowy

- 1) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.02.2017 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 01.10.2011 r. Roszczenie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po dacie retroaktywnej a przed końcem okresu ubezpieczenia i roszczenie zgłoszono w okresie dodatkowym.
- 2) Roszczenie zostało zgłoszone w dniu 01.02.2017 r. Zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w dniu 10.01.2017 r., a więc w okresie dodatkowym. Roszczenie – choć zgłoszone w okresie dodatkowym - nie będzie objęte ochroną w ramach przedmiotowej umowy, ponieważ zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce po upływie okresu ubezpieczenia.

6.3.2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o trigger claims made a dodatkowo klient wnioskuje o rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności poza terytorium RP należy zastosować w takim przypadku odpowiednią klauzulę terytorialną uwzględniającą tą zmianę [Klauzula 1M (claims made), Klauzula 2M (claims made) Klauzula 3M (claims made)].

7. Suma gwarancyjna

Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez PZU w porozumieniu z ubezpieczającym. Suma gwarancyjna, określona w umowie, stanowi górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, przy czym taryfa składek wprowadza minimalną sumę gwarancyjną w kwocie 100 000 zł.

Suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy wyrażone są w złotych. Dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity oraz franszyzy redukcyjne wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego, na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie (§ 11 ust. 4 OWU i OWU szpitali).

W ramach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione podlimity kwotowe określające odpowiedzialność PZU za szkody z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego lub ryzyk określonych w klauzulach. Wprowadzanie do ofert podlimitów jest zalecane, gdyż daje to możliwość zmniejszenia ryzyka. Zastosowanie podlimitu i oraz ustalenie jego wysokości powinno być uzależnione od oceny ryzyka. Podlimity sum gwarancyjnych z tytułu ryzyk określonych w klauzulach dodatkowych nie sumują się.

Niedopuszczalne jest:

- 1) ustalanie odrębnych podlimitów powyżej sumy gwarancyjnej na poszczególne klauzule dodatkowe;
- 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub podlimitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
- 3) wprowadzanie zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej;

W ramach sumy gwarancyjnej PZU pokrywa dodatkowe koszty, o których mowa w § 12 OWU i OWU szpitali. PZU nie odpowiada za dodatkowe koszty, które wynikły z braku zgody ubezpieczonego na zawarcie przez PZU ugody z poszkodowanym lub zaspokojenia jego roszczeń. Niniejsze postanowienie stosuje się również w przypadku, gdy wysokość zasądzzonego świadczenia pieniężnego jest wyższa niż miało to wynikać z proponowanej przez PZU ugody (§ 11 ust. 6 OWU i OWU szpitali).

CZĘŚĆ V

TARYFY SKŁADEK

1. Postanowienia wspólne dla taryf

1.1. Użyte w taryfach składek za dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pojęcia oznaczają:

- 1) składka podstawowa – składka ustalona zgodnie z zasadami określonymi w danej taryfie składek, nie uwzględniająca zwwyżek i zniżek taryfowych ani zwwyżek i zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (pozataryfowych);
- 2) składka taryfowa - składka ustalona zgodnie z zasadami określonymi w danej taryfie, uwzględniająca zwwyżki i zniżki taryfowe (zastosowane do składki podstawowej), jednak nie uwzględniająca zwwyżek i zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (pozataryfowych);
- 3) składka ubezpieczeniowa – składka należna PZU od ubezpieczającego za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, ustalona jako iloczyn składki taryfowej oraz zniżek i zwwyżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (zniżek pozataryfowych); w przypadku, gdy zwwyżki lub zniżki wynikające z indywidualnej oceny ryzyka (zniżki pozataryfowe) nie znajdą zastosowania wysokość składki ubezpieczeniowej jest równa wysokości składki taryfowej.

1.2. Możliwość zastosowania zwwyżek lub zniżek wynikających z indywidualnej oceny ryzyka (poza taryfowych) wynika z kompetencji, uregulowanych odrębnymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w PZU.

1.3. Składkę taryfową ustala się następująco:

- a) najpierw ustala się składkę podstawową; szczegółowe zasady ustalenia składki podstawowej dla danego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego określone zostały w poszczególnych taryfach składek,
- b) następnie do ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

Zwwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwwyżka, a następnie zniżka¹³.

Z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej.

Jeżeli zawierana umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej.

1.4. W razie opłacania składki w ratach za ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, niezapłacenie raty składki w terminie oznaczonym przez PZU nie powoduje ustania odpowiedzialności PZU. Odpowiedzialność PZU trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu (art. 12 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Natomiast brak jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych regulacji dotyczących sytuacji, gdy składka opłacana jest jednorazowo, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zaplaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie.

1.5. Jeżeli w umowie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zaplaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.

¹³ odpowiednio § 7 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA i § 5 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

1.6. W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki dokonywany jest przez PZU z uwzględnieniem zasady, iż składka należy się tylko za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Do ustalenia kwoty zwrotu składki stosuje się zasadę proporcjonalności (pro rata temporis). Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

2. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwana dalej „taryfą dla podmiotu innego niż szpital”)

2.1. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na wniosek ubezpieczającego. Ocenę ryzyka dokonuje się w oparciu o informacje przekazane przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie.

2.2. Umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego na okres krótszy niż 12 miesięcy, ustalając składkę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 taryfy dla podmiotu innego niż szpital, przy zastosowaniu Tabeli frakcyjnej (Tabela III).

2.3. Składkę podstawową ustala się w zależności od:

1) grupy, do której należy podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital, zgodnie z poniższym:

a) grupa I, do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, w ramach których świadczenia zdrowotne są wykonywane wyłącznie przez pielęgniarki, położne lub inne osoby wykonujące zawód medyczny inny niż zawód lekarza lub lekarza dentystry,

b) grupa II, do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, neonatologii, urologii, urologii dziecięcej,

c) grupa III - do której zalicza się podmioty lecznicze inne niż prowadzące szpital, które udzielają świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej, kardiologii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, neonatologii, urologii, urologii dziecięcej;

2) liczby zatrudnionych lekarzy (grupa II i III) albo liczby zatrudnionego personelu medycznego (grupa I).

2.4. Składkę taryfową za okres 12 miesięcy ustala się zgodnie z § 4 - 8 taryfy dla podmiotu innego niż szpital w ten sposób, że:

1) najpierw ustala się składkę podstawową:

a) na podstawie Tabeli I ustala się wysokość składki odpowiednią dla grupy ryzyka, do której został zakwalifikowany podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital,

b) następnie tak ustaloną składkę mnoży się przez współczynnik korygujący określony dla danej liczby zatrudnionego personelu medycznego albo danej liczby zatrudnionych lekarzy przy czym, gdy podmiot leczniczy inny niż prowadzący szpital został zakwalifikowany do:

- grupy I, stosuje się współczynnik korygujący zależny od liczby zatrudnionego personelu medycznego,
- grupy II lub III, stosuje się współczynnik korygujący zależny od liczby zatrudnionych lekarzy,

c) następnie do tak ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

- 2.5. Zwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwyżka, a następnie zniżka¹⁴.
- 2.6. Przez podstawowy zakres ubezpieczenia rozumie się zakres ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Przez klauzule dodatkowe rozumie się:
- Klauzulę rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych,
 - Klauzulę dodatkowych kosztów prawnych,
- stanowiące załącznik do uchwały nr UZ/416/2014 Zarządu PZU SA z dnia 30 grudnia 2014 r.

Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych:

1. Klauzula ma zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

2. PZU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej:

1) obejmuje ochroną ubezpieczeniową ponad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia dla tej klauzuli zwrot ubezpieczającemu:

a) uzasadnionych okolicznościami zdarzenia, kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
b) niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą PZU, przy czym ich wysokość ustalana jest według minimalnych stawek za czynności radcy prawnego lub adwokata, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego lub rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokata;

2) obejmuje ponadto ochroną ubezpieczeniową w wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia dla tej klauzuli zwrot ubezpieczającemu:

a) uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
b) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

Klauzula rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych

1. Klauzula ma zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. PZU za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, rezygnuje z prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego, z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania za szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.

W przypadku podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital, który w ramach zawartej umowy udziela świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitala stosuje się zwyżkę składki podstawowej o 100%¹⁵.

¹⁴ § 5 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

¹⁵ § 6 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

2.7. Z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej w wysokości:

- 1) 30% - w przypadku wypłaty jednego odszkodowania w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
- 2) 60% - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

2.8. Jeżeli zawierana umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej w wysokości 5%.

2.9. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej

Co do zasady płatność składki ubezpieczeniowej jest jednorazowa.

W przypadku umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawieranej na okres 12 miesięcy, na wniosek ubezpieczającego, składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Możliwe są następujące schematy płatności – półroczny, kwartalny, dwumiesięczny i miesięczny.

Kwota składki ubezpieczeniowej jest określona i opłacana w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza. Raty składki ubezpieczeniowej powinny być w równej wysokości, przy czym, w przypadku, gdy raty składki ubezpieczeniowej nie są wyrażone kwotą pełnych złotych, wówczas końcówki wyrażone w groszach dolicza się do pierwszej raty, a pozostałe raty wyraża się w kwocie w pełnych złotych.

3. Taryfa składek za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA (dalej „taryfa”)

Minimalna suma gwarancyjna za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wynosi 100.000 złotych.

Wysokość składki za okres 12 miesięcy ustalono w złotych dla sum gwarancyjnych w przedziale od 100 000 PLN do 2 000 000 PLN. W celu ustalenia składki ubezpieczeniowej dla sumy gwarancyjnej wyższej niż 2 000 000 PLN składkę ustaloną dla 2 000 000 zł mnoży się przez współczynnik ILF sumy gwarancyjnej.

Dla stałych sum gwarancyjnych wysokość składki ubezpieczeniowej została określona w tabelach w taryfie. Dla sum gwarancyjnych określonych w przedziałach pomiędzy stałymi sumami gwarancyjnymi, składka ubezpieczeniowa ustalana jest przez system Everest przy pomocy interpolacji liniowej (składka wylicza jest zgodnie z regułą matematyczną).

W przypadku ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy składkę ustala się według tabeli frakcyjnej. Składkę taryfową ustaloną za 12 miesięczny okres ubezpieczenia mnoży się przez wskazany w tabeli procent składki rocznej. Za ubezpieczenie na okres dłuższy niż 12 miesięcy składkę ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności (pro rata temporis).

Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od wskazanych parametrów w pkt 2.3, oraz dodatkowo od wybranego zakresu (podstawowy, rozszerzony) oraz oświadczenia o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziale szpitala.

Dodatkowo dokonuje się zaszeregowania do grupy ryzyka zgodnie z pkt 2.3.

Składkę podstawową za podstawowy albo rozszerzony zakres ubezpieczenia wylicza się zgodnie z Tabelą I, następująco:

- 1) składkę podstawową ustala się dla wybranej wysokości sumy gwarancyjnej, grupy ryzyka oraz zakresu ubezpieczenia;
- 2) składka podstawowa za rozszerzony zakres ubezpieczenia stanowi sumę składek podstawowych za podstawowy zakres ubezpieczenia i rozszerzenie, podanych w Tabeli I.

Składkę ustaloną jak powyżej należy skorygować o współczynnik korygujący, ustalony dla wybranej liczby zatrudnionych lekarzy (w przypadku podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital należących do grupy II albo grupy III) albo wybranej liczby zatrudnionego personelu medycznego (w przypadku podmiotów leczniczych innych niż prowadzące szpital należących do grupy I).

Ileokroć mowa jest o podlimicie, przyjmuje się, że jest on wyodrębniony w granicach sumy gwarancyjnej i odnosi się do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

Składki podstawowe za klauzule dodatkowe oblicza się w następujący sposób:

Klauzula Nr 1M - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 2M - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 3M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy;

Klauzula Nr 4M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy dla III grupy ryzyka, naliczonej od wysokości wnioskowanego podlimitu dla klauzuli 4M;

Klauzula Nr 4AM - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy dla III grupy ryzyka, naliczonej od wysokości wnioskowanego podlimitu dla klauzuli 4AM;

Klauzula Nr 5 - 0,5% od podlimitu;

Klauzula Nr 6 - dla podlimitu w wysokości 500 000 zł składka wynosi 3 850 zł, dla podlimitu w wysokości innej niż 500 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 3 850 zł i wartość współczynnika ILF = 30;

Klauzula Nr 7A - 0,9% dla podlimitu $\leq 100\,000$ zł, dla wyższych podlimitów niż 100 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;

Klauzula Nr 13M - 25% składki za wybrany zakres ubezpieczenia (zakres podstawowy albo rozszerzony) naliczonej od podlimitu wnioskowanego dla tej klauzuli.

W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień odmiennych – zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego i zastosowania triggera claims made – przysługuje zniżka składki podstawowej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 3-6 taryfy, w wysokości 10%.

4. Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA, zwana dalej „taryfą dla szpitali”)

4.1. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na wniosek ubezpieczającego. Ankiety medycznej oceny ryzyka, zwane dalej „ankietami”, stanowią załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego i wypełniane są przez ubezpieczającego wraz z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego przed jej zawarciem. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe ubezpieczenie, dyrektor biura lub dyrektor w biurze Centrali PZU, do którego kompetencji należy zarządzanie ubezpieczeniem OC może ustalić odmienny sposób postępowania.

4.2. Umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawiera się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego na okres krótszy niż 12 miesięcy, ustalając składkę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 10 taryfy dla szpitali, przy zastosowaniu Tabeli frakcyjnej (Tabela VI).

4.3. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej za pomocą zakładu leczniczego.

4.4. Podmiot leczniczy prowadzący szpital - poza działalnością leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - może również wykonywać działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, a także świadczenia zdrowotne opieki doraźnej.

4.5. Ocena ryzyka

4.5.1 Dla celów oceny ryzyka rodzaje wykonywanej działalności zostały skategoryzowane następująco:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - kategoria H, w tym:

a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – podkategoria H1;

b) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – podkategoria H2;

- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – kategoria A;
- 3) świadczenia zdrowotne opieki doraźnej – kategoria E.

Przykład:

- 1) *W przypadku podmiotu leczniczego, który prowadzi szpital, zakład-opiekuńczo leczniczy, przychodnię przyszpitalną oraz szpitalny oddział ratunkowy przyjmuje się, że prowadzi działalność leczniczą w następujących kategoriach: H1, H2, A, E.*
- 2) *W przypadku podmiotu leczniczego, który prowadzi szpital, zakład-opiekuńczo leczniczy, przychodnię przyszpitalną przyjmuje się, że prowadzi działalność leczniczą w następujących kategoriach: H1, H2, A.*

4.5.2. Ankiety

W przypadku podmiotów leczniczych prowadzących szpital niezbędne do oceny ryzyka jest wypełnienie przez ubezpieczającego ankiet. Na ankiety przeznaczone dla podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne składają się: ankieta ogólna, ankieta roszczeń oraz ankieta dotycząca poszczególnych oddziałów (anestezjologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, ortopedia i traumatologia, pediatria, zachowawczy, zabiegowy, inny). Ankieta przeznaczona dla podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne składa się z ankiety ogólnej oraz ankiety roszczeń.

4.5.3. Klasy ryzyka

Wyróżnia się sześć klas ryzyka (I - VI), według których zaszeregowane są podmioty lecznicze prowadzące szpital:

- 1) zaszeregowanie do klas ryzyka I - V następuje w zależności od liczby punktów uzyskanych w ankietach (Tabela I);
- 2) zaszeregowanie do VI klasy ryzyka dokonuje się w przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego ankiet lub dostarczenia przez ubezpieczającego ankiet z niepełnymi lub niepoprawnymi danymi, co powoduje uniemożliwienie wykorzystania ankiet do oceny ryzyka;
- 3) zaszeregowanie do danej klasy ryzyka dokonuje się odrębnie dla każdej kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E). Zwracamy uwagę, że kategoria H (działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) składa się z dwóch podkategorii: H1 - lecnictwo szpitalne i H2 – lecnictwo „nieszpitalne”; jeżeli podmiot leczniczy prowadzący szpital udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych (podkategoria H1) oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (podkategoria H2) dla celów kwotacji składki w zakresie kategorii H przyjmuje się klasę ryzyka ustaloną dla podkategorii H1;
- 4) w przypadku podmiotu leczniczego, który jest w trakcie rejestracji lub podmiotu nowoutworzonego (wykonywanie działalności leczniczej poniżej 1 roku) prowadzącego szpital, zaszeregowanie do danej klasy ryzyka dla każdej z kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E) dokonuje pracownik zespołu właściwego do medycznej oceny ryzyka w biurze Centrali PZU, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.

4.5.4. Wielkość kategoryzacji podmiotów leczniczych prowadzących szpital

Na podstawie ankiet ustala się również wielkość kategoryzacji podmiotów leczniczych. Wyróżnia się cztery wielkości kategoryzacji podmiotów leczniczych prowadzących szpital: mały, średni, duży lub bardzo duży. Zaszeregowanie do danej wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital dokonuje się w zależności od liczby punktów uzyskanych w ankietach (Tabela V) taryfy dla szpitali; w przypadku odmowy wypełnienia przez ubezpieczającego ankiet lub dostarczenia przez ubezpieczającego ankiet z niepełnymi lub niepoprawnymi danymi, co powoduje uniemożliwienie wykorzystania ankiet do oceny ryzyka, stosuje się współczynnik korygujący przypisany do wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital powyżej 1350 (bardzo duży).

4.6. Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od:

- 1) klas ryzyka, do których został zaszeregowany podmiot leczniczy prowadzący szpital, dla każdej z kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E) udzielanych przez ten podmiot leczniczy prowadzący szpital;

- 2) kategorii świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy prowadzący szpital;
- 3) rodzaju podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
- 4) obrotu z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy podmiotu leczniczego prowadzącego szpital;
- 5) wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

4.7. Składkę taryfową za okres 12 miesięcy ustala się zgodnie z § 6 - 9 taryfy dla szpitali w ten sposób, że:

- 1) najpierw ustala się składkę podstawową na podstawie § 6 (Tabele I – V) taryfy dla szpitali:
 - a) na podstawie Tabeli I taryfy dla szpitali w oparciu o liczbę zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach działalności leczniczej (H, A, E) ustala się klasy ryzyka dla poszczególnych kategorii,
 - b) na podstawie Tabeli II taryfy dla szpitali ustala się dla każdej z kategorii działalności leczniczej wysokość składki odpowiedniej dla danej klasy ryzyka ustalonej zgodnie z lit. a),
 - c) składki ustalone dla poszczególnych kategorii sumuje się,
 - d) w przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzący szpital należy do jednego z rodzajów podmiotów wskazanych w Tabeli III taryfy dla szpitali sumę składek, o której mowa w lit. c) mnoży się przez współczynnik korygujący wskazany w Tabeli III taryfy dla szpitali;
 - e) wysokość składki o której mowa w lit. c) albo składki o której mowa w lit. d), jeżeli została ustalona z uwagi na rodzaj podmiotu leczniczego prowadzącego szpital mnoży się przez wysokość współczynnika korygującego uzależnioną od wysokości obrotu z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zgodnie z Tabelą IV taryfy dla szpitali, a następnie przez wysokość współczynnika korygującego uzależnioną od wielkości kategoryzacji podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, zgodnie z Tabelą V taryfy dla szpitali;
- 2) następnie do tak ustalonej składki podstawowej stosuje się zwwyżki i zniżki taryfowe.

4.8. Zwwyżki i zniżki składki podstawowej nalicza się kolejno metodą iloczynową za podstawowy zakres ubezpieczenia (bez klauzul dodatkowych) i za poszczególne klauzule dodatkowe, w pierwszej kolejności zwwyżka, a następnie zniżka¹⁶.

4.9. Przez podstawowy zakres ubezpieczenia rozumie się zakres ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu. Przez klauzule dodatkowe rozumie się:

- Klauzulę rezygnacji z prawa dochodzenia roszczeń regresowych,
- Klauzulę dodatkowych kosztów prawnych,

stanowiące załącznik do uchwały nr UZ/416/2014 Zarządu PZU SA z dnia 30 grudnia 2014 r. (treść klauzul przywołana w pkt 2.6.)

4.10. Z tytułu szkodowego przebiegu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki podstawowej w wysokości:

- 1) 30% - w przypadku wypłaty jednego odszkodowania w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
- 2) 60% - w przypadku wypłaty dwóch lub więcej odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

4.11. Jeżeli zawierana umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego stanowi kontynuację w PZU, ubezpieczającemu przysługuje zniżka składki podstawowej w wysokości 5%.

4.12. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej

Co do zasady płatność składki ubezpieczeniowej jest jednorazowa.

Na wniosek ubezpieczającego, składka ubezpieczeniowa może być rozłożona na raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Kwota składki ubezpieczeniowej jest określona i opłacana w złotych i groszach, z dokładnością do jednego grosza.

¹⁶ § 7 taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalonej uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA

Raty składki ubezpieczeniowej powinny być w równej wysokości, przy czym w przypadku, gdy raty składki nie są wyrażone kwotą pełnych złotych, wówczas końcówki wyrażone w groszach dolicza się do pierwszej raty, a pozostałe raty wyraża się w kwocie w pełnych złotych.

5. Taryfa składek za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ustalona uchwałą nr UZ/488/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządu PZU SA (dalej „taryfa dla szpitali”)

Minimalna suma gwarancyjna za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital wynosi 100.000 złotych.

Wysokość składki za okres 12 miesięcy ustalono w złotych dla sum gwarancyjnych w przedziale od 100 000 PLN do 2 000 000 PLN. W celu ustalenia składki ubezpieczeniowej dla sumy gwarancyjnej wyższej niż 2 000 000 PLN składkę ustaloną dla 2 000 000 zł mnoży się przez współczynnik ILF sumy gwarancyjnej.

Dla stałych sum gwarancyjnych wysokość składki ubezpieczeniowej została określona w tabelach w taryfie. Dla sum gwarancyjnych określonych w przedziałach pomiędzy stałymi sumami gwarancyjnymi, składka ubezpieczeniowa ustalana jest przez system Everest przy pomocy interpolacji liniowej (składka wylicza jest zgodnie z regułą matematyczną).

W przypadku ubezpieczenia na okres krótszy niż 12 miesięcy składkę ustala się według tabeli frakcyjnej. Składkę taryfową ustaloną za 12 miesięczny okres ubezpieczenia mnoży się przez wskazany w tabeli procent składki rocznej. Za ubezpieczenie na okres dłuższy niż 12 miesięcy składkę ustala się w oparciu o zasadę proporcjonalności (pro rata temporis).

Wysokość składki podstawowej uzależniona jest od wskazanych parametrów w pkt 4.6, oraz dodatkowo od wysokości sumy gwarancyjnej oraz zakresu ubezpieczenia.

Składkę podstawową za podstawowy zakres ubezpieczenia albo rozszerzony zakres ubezpieczenia ustala się zgodnie z Tabelą II w taryfie, w następujący sposób:

- składkę podstawową ustala się dla wybranej wysokości sumy gwarancyjnej, klasy ryzyka oraz zakresu ubezpieczenia;
- jeżeli podmiot leczniczy prowadzący szpital udziela świadczeń zdrowotnych w więcej niż jednej kategorii świadczeń zdrowotnych (H, A, E), o których mowa w § 4, składki podstawowe ustalone odrębnie dla każdej kategorii świadczeń zdrowotnych sumuje się;
- składka podstawowa za rozszerzony zakres ubezpieczenia stanowi sumę składek podstawowych za podstawowy zakres ubezpieczenia i rozszerzenie.

Ileokroć mowa jest o podlimicie, przyjmuje się, że jest on wyodrębniony w granicach sumy gwarancyjnej i odnosi się do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia.

Składki podstawowe za klauzule dodatkowe oblicza się w następujący sposób:

- Klauzula Nr 1M - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 2M - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 3M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy;
- Klauzula Nr 4M - 120% składki ustalonej za zakres podstawowy naliczanej od wysokości wnioskowanego dla klauzuli nr 4M podlimitu;
- Klauzula Nr 4AM - 100% składki ustalonej za zakres podstawowy naliczanej od wysokości wnioskowanego dla klauzuli nr 4AM podlimitu;
- Klauzula Nr 5 - 0,5% od wysokości podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 5;
- Klauzula Nr 6 - dla podlimitu w wysokości 500 000 zł składka wynosi 3 850 zł, dla podlimitu w wysokości innej niż 500 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;
- Klauzula Nr 7A - 0,9% dla podlimitu ≤100 000 zł, dla wyższych podlimitów niż 100 000 zł składkę ustala się przyjmując do wyliczeń składkę dla podlimitu 500 000 zł w wysokości 1 655 zł i wartość współczynnika ILF = 30;
- Klauzula Nr 10 - 1% od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 10;
- Klauzula Nr 13 - 25% składki podstawowej za wybrany zakres ubezpieczenia (zakres podstawowy albo rozszerzony) naliczonej od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 13M;
- Klauzula Nr 80 - 2% od podlimitu wnioskowanego dla klauzuli nr 80;
- Klauzula Nr 81 - 60% składki ustalonej za zakres podstawowy.

W przypadku wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień odmiennych – zmiany definicji wypadku ubezpieczeniowego i zastosowania triggera claims made – przysługuje zniżka składki podstawowej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 3-6 taryfy, w wysokości 10%.

CZĘŚĆ VI

1. Druki

- 1.1. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą drukowaną z systemu Everest.
- 1.2. W przypadku Klientów Korporacyjnych do umowy ubezpieczenia, zarówno w zakresie obowiązkowym jak i dobrowolnym, będzie miał zastosowanie druk „Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC Medyczne”, który otrzymał nr PZU SA 6S03/III.
- 1.3. Wypełnienie wniosku o ubezpieczenie jest obligatoryjne i stanowi integralną część polisy. Wyjątkiem od powyższej zasady jest złożenie oferty w odpowiedzi na SIWZ.

2. Zasady obsługi szkód

2.1. Obsługa szkód osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Osobowych i Świadczeń w Zespole Likwidacji Szkód Medycznych, Osobowych i Rent oraz Zespole Obsługi Szkód Osobowych z Ubezpieczeń OC Niekomunikacyjnych.

Szczegółowe zasady odnoszące się do obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital zostały określone w okólniku O/10/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Procedury obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń OC podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz w okólniku nr O/8/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Procedury obsługi szkód osobowych z ubezpieczeń OC.

2.2. Obsługa szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego innego niż prowadzący szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w Zespole Obsługi Szkód z Ubezpieczeń OC.

2.3. Obsługa szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital odbywa się w Centrum Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych w Zespole Obsługi Szkód z Ubezpieczeń OC Klientów Korporacyjnych.

2.4. Szczegółowe zasady odnoszące się do obsługi szkód majątkowych z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz podmiotu leczniczego prowadzącego szpital zostały określone w okólniku nr O/23/2017 Dyrektora Biura Obsługi Szkód i Świadczeń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie jednolitych Procedur obsługi szkód majątkowych.

3. Statystyka i ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa systemowego produktu „OC Medyczna”, w którego skład wchodzi ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.

Zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należą do 13 grupy ustawowej - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące:

- 1) Ubezpieczeń obowiązkowych ewidencjonowane są na następujących kontach analitycznych:
D16410 – OC Medyczna KM (ubezpieczenie obowiązkowe)

- 2) D16420 – OC Medyczna KK (ubezpieczenie obowiązkowe) Ubezpieczeń dobrowolnych ewidencjonowane są na następujących kontach analitycznych:
D16430 – OC Medyczna KM (ubezpieczenie dobrowolne)
D16440 – OC Medyczna KK (ubezpieczenie dobrowolne)